3.室早的类型

①联律：二联律、三联律（2 个窦性搏动后出现 1 个室早）　1窦+1室早

②成对室早：连续出现 2 个室早（吓死单身狗）

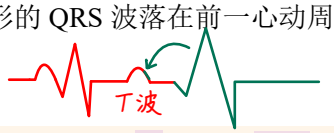
③多源/形室早：2 种以上的异位起搏点所致同一导联中出现 2 种以上不同形态的 QRS 波

④间位室早：室早插入 2 个窦性搏动之间、后无代偿间隙

⑤R-on-T：室早宽大畸形的 QRS 波落在前一心动周期的 T 波，特别是落在易损期是 R-on-T 中最危险的类型，极易导致室速、室颤

易损期:针对整个心室

有效不应期　相对不应期



每个心室肌细胞兴奋性恢复的时间和速度不同,若有冲动落在这个时期,心室运动非常容易不协调

《诊断学》：**室颤先兆**：室早频发＞5 次/分、成对室早、短阵室速、多源室早、落在前一心搏的易损期（2+3=5 多损）　连续3个室早

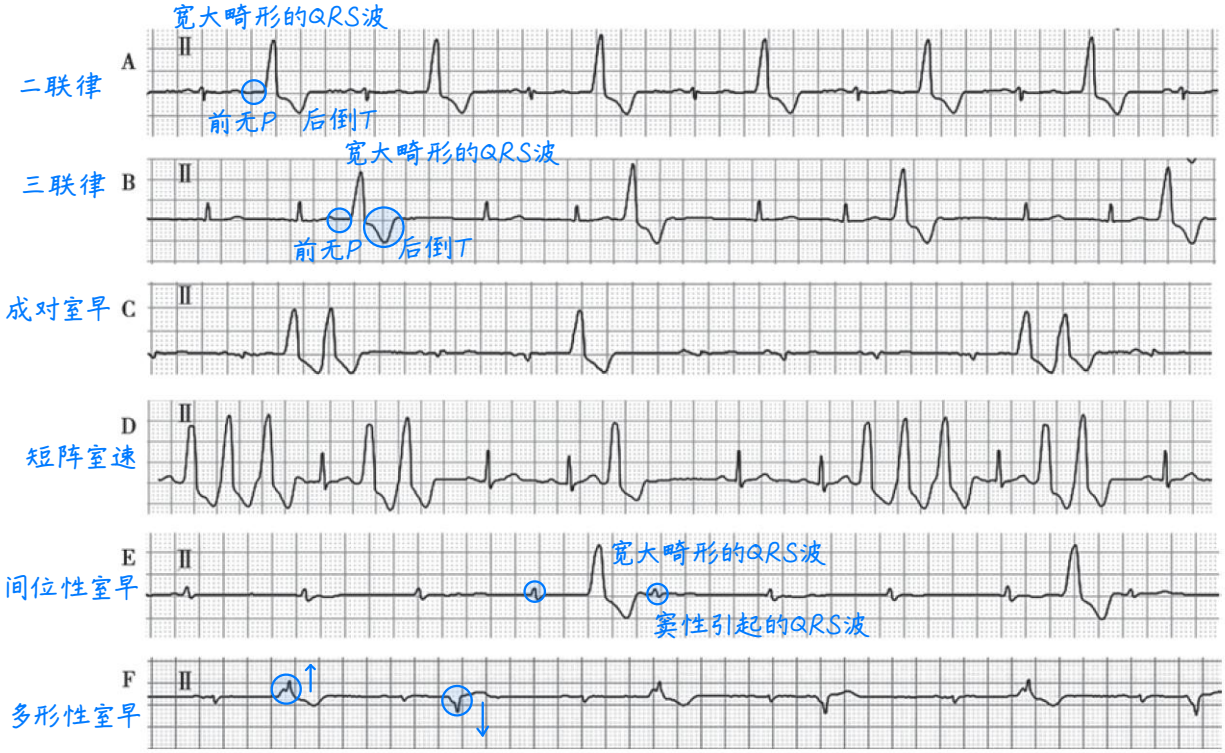


图 3-3-21　室性期前收缩的类型

A. 每个窦性搏动后跟随一个室早，为二联律；B. 每两个窦性搏动后跟随一个室早，为三联律；C. 第 3、4 个 QRS 波群连续出现，为成对室早；D. 第 1、2、3 个 QRS 波群连续出现，为短阵室速。E. 第 5、10 个 QRS 波群提前发生，其后无代偿间歇，为间位性室早；F. 第 2、4 个 QRS 波群形态不一，为多形性室早。

小结：

	房早	交界早	室早
发病率	室早＞房早＞交界早		
多见于	正常人	器质性心脏病	器质性心脏病
代偿间隙	不完全性	完全性	完全性没走希浦系统
心电图	提早出现房性 P 波 P'R 间期≥0.12s	逆行 P 波（II/III/aVF 倒置），逆行 P 波在提早出现 QRS 波的前、后、或重叠	提早出现宽大畸形 QRS 波， 前无 P、后倒 T